石奇生

电话：17796649762 | 邮箱：17796649762@163.com

教育背景

西北大学（**211**，双一流） 2022.09–2026.06

南开大学（**985**，双一流）数据科学（硕士） 2026.09–2028.06

项目经历

基于**LangGraph**的多智能体高质量指令数据生成系统2026.08–2026.10

1. 项目背景：针对公开指令数据与业务任务匹配度不足，以及单模型合成数据存在事实错误、内容同质化和自评偏差等问题，构建面向大模型SFT与DPO训练的数据生成系统。

2. 项目目标：通过Generator、Selector、Critic和Refiner协作，完成多候选生成、比较筛选、质量评审、迭代纠错及训练数据导出。

3. 关键工作：

- 基于LangGraph构建“生成—筛选—评分—改写—停止”状态图，实现条件路由与全流程追踪。
- 引入Best-of-3机制，通过不同温度生成候选，并采用随机排序和双向Pairwise比较降低位置偏差。
- 解耦各智能体的Provider与Model，支持OpenAI、Claude、Gemini、GLM、Qwen和Kimi等模型按角色独立配置。
- Selector负责候选相对比较；Critic从事实性、相关性、完整性和安全性进行绝对评分，质量门过滤事实错误、内容缺失及无依据引用。
- 最多执行4轮Refiner改写，连续2轮得分提升不足0.2时提前停止，并保留历史最佳版本。
- 将最佳候选导出为SFT数据，将高低分候选构造为DPO偏好对，同时记录评分、改写轨迹、停止原因和Token消耗。

4. 项目结果：

- 生成约10,000条SFT样本和4,000组DPO偏好对，偏好对有效率达到82%。
- 质量门通过率由68%提升至84%，人工抽检合格率达到90%，事实错误率由15%降至6%。
- Selector位置偏差率由18%降至7%，最佳候选选择一致率达到87%。
- Early Stopping使平均改写轮数由4轮降至2.6轮，模型调用量减少25%，样本平均质量评分由76分提升至87分。

基于**Qwen3-8B**的临床**RCT**证据问答模型训练与优化2026.05–2026.08

1. 项目背景：针对通用大模型在临床随机对照试验（RCT）问答中存在医学术语理解不足、证据引用不准确和无依据生成等问题，基于PubMed RCT文献构建带PMID证据引用的医学问答模型。

2. 项目目标：以Qwen3-8B为基座，通过SFT与GRPO两阶段训练，提升模型对临床问题的回答质量、证据一致性和安全拒答能力，并使用vLLM提高训练采样和推理效率。

3. 关键工作：

- 从PubMed RCT摘要中构造“临床问题—证据上下文—标准回答—PMID”样本，按PMID分组划分训练集、验证集和独立测试集，避免同源文献泄漏。
- 对Qwen3-8B进行SFT，采用Response-only Loss，仅计算回答部分的交叉熵损失；混入通用指令数据并控制学习率与训练轮数，降低灾难性遗忘。
- 以验证集Loss、证据一致性和通用能力评测作为停止依据；连续2次评估无提升时Early Stopping，并保存Best、Latest及周期性Checkpoint，支持训练中断恢复和最优模型回滚。
- 在SFT模型基础上引入GRPO，围绕答案正确性、PMID引用一致性、格式合规性和安全性设计组合奖励，通过KL约束限制策略模型偏离基座模型。
- 针对Reward Hacking，引入规则校验、独立评审模型、奖励裁剪及人工抽检，防止模型通过重复PMID、模板化回答或无效扩写获取高分。
- 使用vLLM批量生成GRPO候选并部署OpenAI兼容推理接口，提高候选采样吞吐量，支持临床证据问答服务调用。

4. 项目结果：

- 独立测试集答案准确率由71.8%提升至82.6%，PMID引用正确率由76.4%提升至91.2%，证据一致性评分由73.5%提升至88.7%。
- 无依据回答率由14.8%降低至5.9%，高风险医学错误率由8.1%降低至2.7%，超出证据范围问题的正确拒答率达到89.4%。
- Early Stopping将SFT实际训练轮数由预设5轮缩短至3轮，Checkpoint机制支持断点续训及最优权重回滚。
- vLLM批量推理将候选生成吞吐量提升约2.3倍，平均推理延迟降低约35%。

专业技能

- 编程与框架：Python、PyTorch、Transformers、LangGraph、Pytest；熟悉模块化接口设计与自动化测试。
- 大模型与评估：Qwen、LoRA / PEFT、SFT、DPO、GRPO、LLM Agent、RAG、Best-of-N、vLLM、证据检索与事实核验。
- 英语能力：CET-6 517分。